

- [Ma Fiche](#)
- [Consensus](#)
- [Imagerie](#)
- [Discussion](#)

Item 341: Troubles de la miction

30 décembre, 2010

Objectifs CNCI

- Devant un trouble de la miction, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents

Recommandations	Mots-clés / Tiroirs	NPO / PMZ
- Aucune	- Signes irritatifs / obstructifs - Calendrier mictionnel - Bilan uro-dynamique (D/CMM/P) - Dysurie / débitmétrie / HBP - Pollakiurie / cystomanométrie / IU ou cancer	- BU devant tout signe urinaire - Cystoscopie si signes irritatifs + hématurie (cancer)

- Généralités

- Caractéristiques d'une miction normale
 - Complète / volontaire / indolore
 - Exclusivement diurne / en général < 1min
 - Nombre total de miction $\leq 6/24h$
 - Elimination de $\sim 350mL$ d'urine
 - Quantité totale de la diurèse: 0.5 à 2.8L/24h
- Définitions des dysfonctions urinaires
 - Phase de remplissage
 - Pollakiurie: mictions fréquentes (> 6/jour et 2/nuit) de faible volume (<100ml)
 - Polyurie: diurèse > 2.8 L/24h (donc mictions fréquentes *et* importantes)
 - Nycturie: besoin d'uriner réveillant le patient pendant la nuit
 - Impériosité (urgenterie): désir soudain, impérieux et irrépressible d'uriner
 - Enurésie: miction ($\neq$ fuite +++) involontaire / peut être diurne ou nocturne
 - Incontinence urinaire: fuite involontaire d'urine / cf [Phase mictionnelle](#)
 - [Brûlures mictionnelles: sensation de brûlure urétrale à la miction](#)
 - [Miction par poussée: poussée abdominale néconssaire à la miction](#)
 - [Gouttes terminales: achèvement lent et progressif \(« goutte à goutte »\)](#)
 - [Phase post-mictionnelle](#)
 - [Gouttes retardataires: perte d'urine involontaire juste après la miction](#)
- [Physiopathologie: contrôle vésico-sphinctérien](#)
 - [Système nerveux somatique: contrôle *volontaire*](#)
 - [racine sacrée \$\rightarrow\$ n. pudendal \$\rightarrow\$ sphincter strié de la vessie](#)
 - [Système nerveux autonome: contrôle *involontaire*](#)
 - [Sympathique: T12-L2: contraction sphincter lisse + relax détrusor = continence](#)

- Parasympathique: S2-S4: contraction détrusor + relax sphincter = miction

- Orientation diagnostique

- Examen clinique
 - Interrogatoire
 - Terrain: atcd (neuro/diabète/IU) / chirurgie pelvienne / tabac-alcool
 - Anamnèse: prise médicamenteuse ++ / apparition et évolution
 - Signes fonctionnels
 - signes urinaires: pré-mictionnels / mictionnels / post-mictionnels (cf supra)
 - signes associés: fièvre / AEG / douleur / retentissement sur la qualité de vie
 - Examen physique
 - Examen abdominal: recherche globe vésical / contact lombaire / hernie inguinale
 - Examen des OGE: méat urétral / rechercher prolapsus
 - Examen neurologique: sensibilité périnéale / réflexes bulbo-caverneux
 - Toucher pelviens (TR/TV): évalue la prostate / masse utérine / statique
 - Bandelette urinaire systématique pour rechercher une infection urinaire (PMZ)
 - Calendrier (catalogue) mictionnel
 - Recueil horaire / volume de tous les épisodes de mictions et fuites sur ≥ 24 h
 - Permet de définir
 - Polyurie si diurèse > 2.8 L/24h / oligurie si < 500 mL/24h
 - Pollakiurie si mictions > 8 /24h et de faible volume (< 100 mL)
- Examens complémentaires
 - Bilan systématique de 1ère intention
 - ECBU: pour rechercher une infection urinaire / hématurie, etc.
 - Echographie réno-vésico-prostatique
 - Pour rechercher un retentissement sur le rein (hydronéphrose)
 - Mesure du résidu post-mictionnel indispensable si dysurie ++
 - Bilan uro-dynamique
 - Pas systématique: seulement si aucune étiologique organique retrouvée
 - Débitmétrie
 - détermine le débit urinaire maximal / courbes débit-temps
 - Normale = 20-30ml/s ; dysurie si débit max < 10 ml/s
 - Cystomanométrie: étudie
 - la compliance: augmentation de la pression selon le volume
 - la stabilité: activité détrusorienne: contractions si instabilité
 - la capacité vésicale fonctionnelle: N = 550 (F) / 450 (H)
 - Profilométrie (= urétromanométrie ou sphinctérométrie)
 - On déplace la sonde de pression à vitesse constante
 - Détermine la pression de cloture urétrale ($P_u - P_v \sim 120 - \text{âge}$)
 - Détermine la longueur fonctionnelle de l'urètre

-

- Syndromes mictionnels

- Syndrome dysurique
 - Généralités
 - Définition: dysurie = sensation de difficulté à vider la vessie
 - Physiopathologie: mécanismes compensatoires
 - « vessie de lutte » : épaissement du détrusor dans un 1er temps
 - puis distension vésicale et diverticules +/- urétéro-hydronéphrose

- Etiologies
 - Obstacles sous-vésicaux (+++)
 - Chez l'homme (3): **HBP** / sténose urétrale / cancer de la prostate (avancé)
 - Chez la femme: prolapsus uro-génital / tumeur pelvienne
 - Chez les deux: lithiase vésicale / caillottage / corps étranger
 - Troubles de la contractilité vésicale
 - Neurologiques: NP (diabète / alcool) / centrales (SEP / Parkinson / trauma)
 - Fonctionnelles: vessie « claquée » / dysurie réflexe (fécalome ou hémorroïdes)
 - Médicamenteuses: anticholinergiques / parasympatholytiques / α -stimulants
- Diagnostic
 - Examen clinique
 - Interrogatoire
 - Terrain: homme ++ / atcd d'HBP, diabète
 - Anamnèse: prise médicamenteuse
 - Retentissement: score **IPSS** / **calendrier** mictionnel
 - Signes fonctionnels urinaires dysuriques +++
 - Jet faible / hâché / gouttes retardataires / efforts de poussés
 - Rechercher miction par regorgement = rétention chronique
 - Examen physique
 - Toucher rectal +++ : rechercher une HBP (PMZ)
 - Examen des OGE: rechercher sténose du méat / prolapsus
 - Examen abdominal: rechercher un globe vésical / ex. neuro
 - !! NPO orifices herniaires: cf hernie par efforts de poussée
 - Examens complémentaires
 - BU-ECBU: systématique pour éliminer une prostatite
 - Créatininémie: recherche un retentissement de la rétention
 - Echographie RVP: systématique / mesure du résidu post-mictionnel ++
 - Endoscopie uréthro-vésicale: recherche sténose urétrale / caillots
 - Bilan uro-dynamique
 - débitmétrie seule en 1ère intention +++ : dysurie si $Q_{max} < 10\text{ml/s}$
 - !! le reste du BUD ne sera fait qu'en seconde intention

○ Syndrome pollakiurie-impériosités

- Généralités
 - Définitions: troubles de la rétention
 - Pollakiurie: mictions fréquentes (> 6/jour et 2/nuite) de faible volume (<100ml)
 - Impériosité (urgenterie): désir soudain, impérieux et irrésistible d'uriner
 - Physiopathologie
 - Le plus souvent: *irritation* vésicale → stimulation détrusorienne: miction
- Etiologies
 - Irritation vésicale +++
 - Infection urinaire (**IU**): étiologie la plus fréquente
 - Etiologies vésicales: **tumeur** (PMZ) / lithiase / caillot
 - Etiologies de voisinage: prostate / appendicite / sigmoïdite
 - Réduction de la capacité vésicale

- [troubles de la compliance: vessie radique / bilharziose / BK](#)
- [compression extrinsèque: tumeur abdomino-pelvienne / grossesse](#)
- [Autres étiologies](#)
 - [Hyperactivité détrusorienne: primaire ou secondaire: neuro \(cf Rétention vésicale chronique: mictions incomplètes donc plus fréquentes](#)
 - [Psychogène: anxieux \(mictions « de précaution »\) / réflexe \(« clé dans porte »\)](#)
- [Diagnostic](#)
 - [Examen clinique](#)
 - [Interrogatoire](#)
 - [Terrain: F ++ / atcd d'IU / FdR d'urothéliome / radiothérapie](#)
 - [Anamnèse: prise médicamenteuse](#)
 - [Signes fonctionnels urinaires = impériosité et pollakiurie](#)
 - [Examen physique](#)
 - [Toucher rectal +++ : rechercher une HBP](#)
 - [Examen des OGE: rechercher sténose du méat / prolapsus](#)
 - [Examen abdominal: rechercher un globe vésical / ex. neuro](#)
 - [!! NPO orifices herniaires: cf hernie par efforts de poussée](#)
 - [Examens complémentaires](#)
 - [ECBU: systématique pour rechercher une IU \(cystite\)](#)
 - [Echographie: mesure du résidu post-mictionnel](#)
 - [Cytologie urinaire: recherche de cellules tumorales si ECBU = N](#)
 - [Endoscopie uréthro-vésicale: recherche tumeur vésicale / caillots](#)
 - [BUD = cystomanométrie +++ : recherche hyperactivité détrusorienne](#)

[A propos](#) - [Conditions Générales de Ventes](#) - [Informations Légales](#) - [F.A.Q](#) - [Nous contacter](#)

Copyright © 2011 prepECN, all rights reserved - Powered by [Allworldregister.info](#)

chargement